

Saúde do homem na Atenção Primária: análise das ações governamentais brasileiras no âmbito da Promoção da Saúde

Cléa Conceição Leal Borges¹ (Orcid: 0000-0002-9523-6272) (borges9988@gmail.com)

Ariana Luiza Rabelo¹ (Orcid: 0000-0001-5768-9126) (arianaluizarabelo@gmail.com)

Vinícius de Oliveira Muniz¹ (Orcid: 0000-0001-5605-9720) (viniciusomuniz22@gmail.com)

Nilo Manoel Pereira Vieira Barreto¹ (Orcid: 0000-0002-1397-1362) (nilomanoel@gmail.com)

Jeferson Santos Araújo² (Orcid: 0000-0003-3311-8446) (jeferson.araujo@uffs.edu.br)

Robson Santos Silva³ (Orcid: 0009-0005-3197-1242) (robsonsocial2013@gmail.com)

Anderson Reis de Sousa¹ (Orcid: 0000-0001-8534-1960) (anderson.sousa@ufba.br)

¹ Escola de Enfermagem, Universidade Federal da Bahia. Salvador-BA, Brasil.

² Universidade Federal da Fronteira Sul. Chapecó-SC, Brasil.

³ Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Salvador-BA, Brasil.

Resumo: A saúde do homem tem sido marcada por padrões de adoecimento e mortalidade que evidenciam desigualdades no acesso e no uso dos serviços de saúde, especialmente na Atenção Primária em Saúde. O objetivo foi analisar documentos das ações governamentais nacionais direcionadas à atenção à saúde do homem no contexto da Atenção Primária em Saúde sob a lente da Promoção da Saúde. Este estudo foi desenvolvido entre 2024 e 2025 com documentos brasileiros normativos, instrutivos e educativos disponíveis nos *sites* governamentais. Os dados foram interpretados à luz do Modelo Integrado de Saúde da População e Promoção da Saúde. Dos 55 registros analisados, 50,9% são instrutivos/educativos, os quais demonstraram “quem”, “o quê” e o “como” da Promoção da Saúde do homem. As ações governamentais brasileiras voltadas à Saúde do Homem, no contexto da Atenção Primária, configuram um esforço relevante, mas ainda marcado por limitações. Há iniciativas importantes em políticas públicas, mas a implementação enfrenta barreiras culturais, estruturais e financeiras. A categorização das ações se ancora nos pilares da promoção da saúde, participação social e empoderamento, evidenciando a necessidade de aprimorar estratégias mais abrangentes a populações específicas.

► **Palavras-chave:** Saúde do Homem. Atenção Primária à Saúde. Promoção da Saúde. Política de Saúde.

Recebido em: 04/04/2025

Revisado em: 16/07/2025

Aprovado em: 22/08/2025

Todos os dados da pesquisa estão disponíveis neste texto.

DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-733120263601613pt>

Editora responsável: Tatiana Wargas da Silva

Pareceristas: Ana Paula Hemmi, Rosa Rocha e Thiago Augusto Soares Monteiro

Introdução

Uma preocupação em todos os sistemas de saúde é atender às necessidades da população masculina e proporcionar qualidade de vida aos homens, considerando o alto custo das tecnologias e a escassez de recursos públicos. Persistem desafios no acompanhamento da situação de saúde de homens na Atenção Primária à Saúde (APS), especialmente no que tange à promoção da saúde, diante da necessidade de construção de consciência sanitária, de uma autopercepção ampliada da saúde, não restritiva à ausência de doença, do reconhecimento das necessidades específicas desse grupo e do papel resolutivo dos serviços ofertados na APS, bem como da garantia de acesso, acolhimento e vínculo nesse nível de atenção (Santos *et al.*, 2024).

Diante desse cenário, a atenção à saúde masculina precisa ser reconhecida como uma prioridade em todos os níveis do sistema de saúde (Sousa, 2020). Nesse nível de atenção, a questão é particularmente crítica diante do contexto global de mortalidade precoce entre homens, associado a elevados índices de morbimortalidade, maior exposição a situações de risco e menor adesão a práticas cuidativas saudáveis. Por essas razões, são necessárias ações governamentais robustas e resolutivas que garantam o cuidado efetivo à saúde dessa população (Sousa, 2020; Brasil, 2018a).

A compreensão desses desafios exige a retomada dos marcos teóricos da Promoção da Saúde, entre os quais se destaca a Carta de Ottawa (OMS, 1986), considerada um referencial internacional para orientar políticas e práticas em saúde. Elaborada na Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, a Carta definiu esse campo como o processo de capacitação das comunidades para melhorar sua qualidade de vida e saúde, com participação ativa e controle social.

A Declaração de Alma-Ata reforça a centralidade dos cuidados primários como estratégia essencial, sobretudo para grupos como a população masculina, historicamente marcada por desigualdades no acesso e uso dos serviços (OMS, 1986; Chan; Wong, 2023; Borges *et al.*, 2021). Desse modo, a Promoção da Saúde é compreendida como o processo de capacitação da comunidade para melhorar sua qualidade de vida e saúde, com participação ativa e controle sobre esse processo. Visa alcançar o bem-estar físico, mental e social, valorizando a saúde como recurso para a vida cotidiana, e não apenas como ausência de doença (OMS, 1986).

Além disso, destaca-se a ênfase nos recursos sociais, pessoais e físicos que sustentam a Promoção da Saúde, como paz, abrigo, educação, alimentação, renda,

ambiente saudável, justiça social e equidade. Para operacionalizar esses princípios, a Carta de Ottawa propõe cinco campos de ação: (1) construção de políticas públicas saudáveis; (2) desenvolvimento de habilidades pessoais; (3) criação de ambientes favoráveis; (4) fortalecimento da ação comunitária; e (5) reorientação dos serviços de saúde (OMS, 1986).

Nesse sentido, na promoção da saúde dos homens na APS, a avaliação das ações governamentais torna-se um mecanismo essencial de gestão, contribuindo para otimizar recursos públicos e qualificar estratégias de cuidado (Pinto; Giovanella, 2018).

Complementarmente, destaca-se o Modelo para Promoção da Saúde da População, de Hamilton e Bhatti (1996), que articula o “quem”, o “o quê” e o “como” da Promoção da Saúde em uma estrutura tridimensional (pictográfica de um cubo). A parte superior “o quem” apresenta as mudanças que ocorrem em níveis diversificados: individual, familiar, comunitário, setorial/sistemático e social/societário. A face do cubo que aborda o “o que” apresenta a existência de múltiplos e abrangentes determinantes da saúde: redes de apoio social, ambientes físicos, práticas de saúde pessoal e habilidades de enfrentamento e desenvolvimento infantil saudável. O lado direito, que descreve o “como”, incorpora as cinco áreas para ação da Promoção da Saúde descritas na Carta de *Ottawa*. As bases de sustentação do cubo estão baseadas em evidências (pesquisa, avaliação) e tomada de decisão (aprendizagem experiencial), que derivam de valores e suposições.

No cenário brasileiro, a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) recomenda a institucionalização da avaliação na APS como instrumento estratégico para qualificar o cuidado. No caso da saúde dos homens, esse cuidado ainda carece de fortalecimento, num contexto marcado por práticas que resultam em altos custos e baixa efetividade dos serviços. Países como Estados Unidos, Inglaterra e México, por exemplo, acumulam mais de 20 bilhões de dólares anuais em gastos relacionados ao que se convencionou chamar de comportamento “tóxico” de saúde masculina (Berbel; Chirelli, 2020).

Torna-se fundamental, assim, adotar abordagens que valorizem a autonomia e a emancipação dos sujeitos, reconhecendo os homens como protagonistas de sua saúde. Isso inclui sua participação ativa na construção da equidade em saúde, entendida como a garantia de oportunidades e acesso a recursos que favoreçam o bem-estar, bem como seu engajamento junto aos diversos setores sociais, governamentais e comunitários (OMS, 1986).

Nesse sentido, o cuidado à saúde dos homens na APS deve adotar um enfoque emancipatório, que vá além da prevenção de doenças e da adesão a comportamentos prescritos. Trata-se de reconhecer os homens como protagonistas do próprio cuidado, fomentando sua autonomia na reconstrução de modos de viver mais saudáveis. Essa abordagem valoriza práticas que estimulem o pensamento crítico, a participação social e o engajamento em ações contextualizadas. Ancorada na equidade, participação e intersetorialidade, a Promoção da Saúde contribui para esse processo ao articular saberes, práticas e políticas que favoreçam o exercício de direitos e a ampliação da capacidade de decisão (Duarte *et al.*, 2012).

Do ponto de vista das políticas públicas que norteiam o Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde (MS) criou em 2008 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH). Sua institucionalização se deu pela Portaria nº 1.944/2009 (Brasil, 2008a, 2009a, 2018a). Sua implantação visa facilitar e ampliar o acesso aos serviços de saúde e às medidas de promoção do cuidado em saúde masculina no âmbito nacional (Rocha *et al.*, 2022; Queiroz *et al.*, 2020). A atualização da PNAISH (Brasil, 2021a) integra o entendimento das expressões das masculinidades como marcador nas práticas de saúde na APS, acolhendo as questões de saúde do homem do campo, do caminhoneiro, dentre outros que necessitam de estratégias específicas frente às suas expressões de masculinidades.

Apesar dos avanços, poucas são as ações governamentais voltadas a este assunto, sendo essenciais reuni-las, o que justifica a realização deste estudo, repercutindo em elevação descontrolável dos gastos no setor saúde mediante a necessidade de reparação de agravos e mortalidade precoce por causas evitáveis (Pinto; Giovanella, 2018) e como reflexo deletério tem-se a superlotação do nível terciário, que culmina com a insustentabilidade do sistema de saúde e a fragilização orçamentária da APS (Nascimento, 2018; Cunha, 2018). Tal cenário é desafiador para os serviços de APS antes mesmo da implementação da PNAISH (Figueiredo, 2005) e confere uma problemática a ser considerada na agenda da saúde coletiva e da esfera governamental brasileira (Schraiber; Gomes; Couto, 2005).

Embora haja estudos publicados acerca das ações governamentais no campo da saúde do homem, há escassez de investigações sob o prisma da Promoção da Saúde, o que contribui para a superação de lacunas no conhecimento científico na área e implicação prática na atenção à saúde, especialmente, na Atenção Primária, tornado o estudo inédito e relevante. Destarte, esta investigação parte do

pressuposto de que as ações em saúde do homem necessitam atender aos construtos teóricos estruturados no Modelo para Promoção da Saúde da População – Modelo de Hamilton e Bhatti (1996).

Sustentados nesses argumentos, surge uma questão norteadora: como as ações governamentais brasileiras, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, têm abordado a saúde do homem, considerando os pressupostos da Promoção da Saúde? Neste sentido, este estudo objetiva analisar os documentos das ações governamentais nacionais direcionadas à atenção à saúde do homem no contexto da Atenção Primária em Saúde sob a perspectiva da Promoção da Saúde.

Metodologia

Estudo exploratório-descritivo, retrospectivo, do tipo Análise Documental, caracterizado pela pesquisa de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico e requerem reelaboração (Carlos; Bellaguarda; Padilha, 2022; Belotti; Iglesias; Avellar, 2019). O protocolo PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses*) auxiliou a sistematização dos dados (Page *et al.*, 2021).

As buscas, tabulação, leitura e interpretação dos documentos ocorreram de novembro de 2024 a fevereiro de 2025, com recorte temporal de 2009 (período de criação da PNAISH) a 2024. Foram critérios de inclusão: documentos normativos nacionais originais disponíveis na íntegra e *on-line* com ações em saúde do homem direcionadas à APS, indexados em fontes oficiais do governo federal, como as Bibliotecas Virtuais do Ministério da Saúde e portais legislativos. Excluíram-se manuscritos, teses, dissertações, monografias, anais de eventos e projetos de pesquisa.

A técnica de busca dos dados foi guiada por descritores e sinônimos, disponíveis nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), semente em português, divididos em: Grupo 1) Saúde do Homem; Homens e Masculino; e Grupo 2) Atenção Primária à Saúde. Foram buscados os termos separadamente a fim de aumentar a sensibilidade; os descritores do Grupo 1 foram operados pelo *booleano* “AND” e cruzados com cada um dos descritores do Grupo 2; para os descritores sinônimos, utilizou-se o operador *booleano* “OR”.

Um instrumento próprio para a extração dos registros foi construído e validado internamente pela equipe de pesquisa vinculada a este estudo, sob recomendações do *Revised Standards for Quality Improvement Reporting Excellence* (SQUIRE 2.0),

contendo: número do documento, ano, título do documento, ação governamental proposta e categorização de acordo os princípios e objetivos da PNPS. Tal procedimento envolveu a participação de três pesquisadores previamente treinados e supervisionados por dois pesquisadores responsáveis. Um material suplementar foi criado com o conteúdo na íntegra dos documentos analisados e está disponível no *link* informado neste manuscrito.¹

A análise dos dados foi estruturada em quatro etapas: 1) Identificação e Seleção – busca/escolha dos documentos relevantes: avaliação dos títulos, resumos e critérios de elegibilidade previamente definidos; 2) Descrição – caracterização detalhada de cada documento (autoria, data de publicação, tipo documental e principais conteúdos); 3) Interpretação – leitura crítica/interpretativa do conteúdo, com foco na identificação de padrões, tendências/relações com o objeto de estudo; 4) Síntese – resultados organizados/apresentados de forma descritiva e concisa para atendimento aos objetivos propostos pela investigação (Carlos; Bellaguarda; Padilha, 2022).

Os achados foram submetidos à interpretação com base no Modelo Integrado de Saúde da População e Promoção da Saúde, o qual se baseia na Carta de *Ottawa* (Hamilton; Bhatti, 1996).

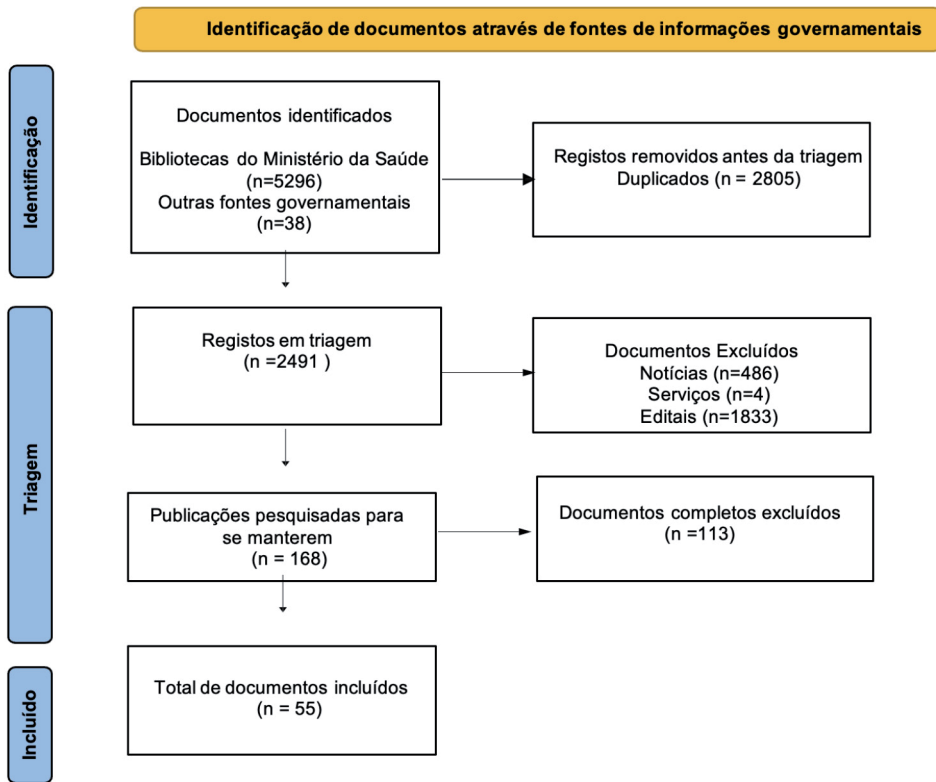
Os dados apreendidos foram organizados em planilhas no *Microsoft Excel*, versão 365/*Windows 11* e submetidos à sistematização e codificação. Este trabalho é oriundo de uma dissertação de mestrado em “Enfermagem e Saúde”, pertencente à linha temática “Saúde de Homens e Masculinidades”, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. A aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa foi dispensável por usar dados secundários de domínio público, conforme Resolução nº 466/2012 (fidedignidade, veracidade, transparência).

Foram utilizados recursos, de forma ética/responsável, da Inteligência Artificial para correção linguística, coesão e coerência da língua portuguesa. Todas as referências analisadas e presentes nos quadros dos resultados estão listadas no material suplementar.

Resultados

O processo de triagem e seleção dos registros está exposto no fluxograma da Figura 1.

Figura 1. Processo de triagem e seleção dos documentos. Salvador, Bahia, Brasil, 2025



Fonte: elaboração própria.

Os achados que compuseram a Análise Documental derivaram dois quadros sinópticos estruturados a partir do caráter dos documentos selecionados, a saber: 1) documentos normativos (Leis, normas, notas técnicas, políticas públicas de saúde, portarias e planos nacionais) e 2) documentos informativos/educativos (manuais, guias de orientação, dados de pesquisa, campanhas publicitárias, cartilhas e *folder*).

Dos 54 documentos analisados, 50% (27/54) são de caráter normativo e 50% (27/54), registros possuem natureza instrutiva e ou educativa (Quadro 1 e 2). Dentre aqueles de caráter normativo, 24,7% (13/54) são notas e orientações técnicas, 9,26% (5/54) são portarias, 16,67% (3/54, cada) correspondem a políticas de saúde, resoluções e Leis. Esses documentos têm como objetivo assegurar melhorias no cuidado à saúde masculina, ampliando o atendimento às demandas em uma perspectiva transversal e

integral, com foco no enfrentamento das desigualdades e iniquidades socioeconômicas e culturais. No que se refere aos anos mais prevalentes de publicações, 20,37% (11/54) foram publicados em 2023; 11,11% (6/54) em 2018/2021 e 9,26% (5/54) em 2017 (Quadro 1). E dentre aqueles de natureza instrutiva e ou educativa, 11,11% (6/54) são guias; 5,56% (3/54) são cartilhas; 3,70% (2/54) correspondem a eventos e 29,63% (16/54) são classificados como outros documentos incluindo relatórios, boletins e materiais educativos. Os instrutivos fornecem orientações e diretrizes sobre diferentes aspectos da saúde masculina, como planejamento familiar, cuidados pré e pós-natais e na prevenção de doenças. Os educativos visam a educação e conscientização sobre questões de saúde masculina, como prevenção de doenças, cuidado pré-natal e participação ativa na paternidade (Quadro 2).

A análise dos documentos categorizados considerou três dimensões: com quem agir, em que agir e como agir, conforme os componentes do Modelo para Promoção da Saúde da População (Quadros 1 e 2).

Dentre os documentos normativos, no que se refere a com quem devemos agir, as ações são dirigidas prioritariamente ao indivíduo, especialmente em temas como autocuidado, saúde sexual e reprodutiva e paternidade. Também se destacam outros níveis de atuação, como a família (em contextos de pré-natal e primeira infância), a comunidade (por meio de ações educativas e campanhas), o setor/sistema (com gestores e profissionais do SUS) e a sociedade (no enfrentamento de estigmas e desigualdades). Quanto a em que devemos agir, os determinantes sociais mais recorrentes são os serviços de saúde, seguidos das práticas e habilidades de enfrentamento individual, da educação e das condições de trabalho.

Também são contempladas variáveis como rede de apoio social, ambientes físicos, renda e status social, biologia e genética e saúde no desenvolvimento infantil, indicando uma abordagem abrangente e intersetorial. Por fim, em relação a como devemos agir, as estratégias mais frequentes estão alinhadas à Carta de *Ottawa*, com destaque para a reorientação dos serviços de saúde, a construção de políticas públicas saudáveis e o desenvolvimento de habilidades pessoais. Também são recorrentes o fortalecimento da ação comunitária e, em menor escala, a criação de ambientes favoráveis à saúde (Quadro 1).

A síntese dos registros normativos, com identificação (ID), suas denominações, ação principal, ano de publicação e categorizações conforme os componentes do Modelo para Promoção da Saúde da População está presente no Quadro 1.

Quadro 1. Categorização das legislações governamentais. Salvador, Bahia, Brasil, 2025

Promoção da Saúde			
Documento, ano e ação:	Com quem devemos agir?	Em que devemos agir?	Como devemos agir?
Portaria nº 1.474/2017. Inclusão da consulta pré-natal do e testes rápidos de HIV e Sífilis para o pai-parceiro.	Indivíduo; Setor/Sistema.	Ambientes físicos; Saúde pessoal e práticas e habilidades de enfrentamento; Serviços de saúde.	1
Portaria nº 1.944/2009. Institui, no SUS, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.	Indivíduo; Família; Comunidade; Setor/Sistema; Sociedade.	Serviços de saúde; Condições de trabalho; Saúde Pessoal e Práticas e Habilidades de Enfrentamento; Educação; Rede de Apoio Social.	1, 2, 3 e 5
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (princípios e diretrizes), 2008.			1, 3 e 5
Portaria nº 2.836/ 2011. Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, <i>Gays</i> , Bissexuais, Travestis e Transexuais.		Renda e status social; Rede de apoio social; Educação; Serviços de saúde; Saúde pessoal e práticas e habilidades de enfrentamento.	1, 2 e 4
Nota Técnica Conjunta no 001/2015. Integralidade da saúde dos homens no contexto do novembro azul.		Renda e status social; Rede de apoio social; Educação; Condições de trabalho; Ambientes físicos; Biologia e genética; Saúde desenvolvimento infantil; Saúde pessoal e práticas e habilidades de enfrentamento; Serviços de saúde.	2 e 5
Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, 2020.		Renda e status social; Educação; Serviços de saúde.	1 e 5

continua...

Promoção da Saúde			
Documento, ano e ação:	Com quem devemos agir?	Em que devemos agir?	Como devemos agir?
Nota Técnica nº 1 SEI/2017. Participação do homem em programa ou atividade de orientação sobre paternidade.	Indivíduo; Comunidade; Setor/Sistema; Sociedade.	Serviços de saúde; Saúde pessoal e práticas e habilidades de enfrentamento; Saúde desenvolvimento infantil; Rede de apoio social; Condições de trabalho; Educação.	1, 2, 3, 4 e 5.
Portaria nº 3.562/2021. A importância da atenção e acolhimento das diversas expressões das masculinidades na Atenção Primária.		Serviços de saúde; Saúde pessoal e práticas e habilidades de enfrentamento; Rede de apoio social; Educação.	1, 2, 4 e 5.
Resolução de Consolidação nº 1/2021. Fortalecimento da autonomia e compromisso com os direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres e homens em todo o seu ciclo de vida.		Serviços de saúde; Saúde pessoal e práticas e habilidades de enfrentamento; Condições de trabalho.	1, 2, 4 e 5.
Nota Técnica nº 14/2021. Revisão da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.		Serviços de saúde; Saúde pessoal e práticas e habilidades de enfrentamento; Educação; Condições de trabalho; Rede de apoio social.	1, 2, 3, 4 e 5.
Nota Técnica nº 11/2021. Estratégias de ampliação do acesso da população masculina à Atenção Primária.		Serviços de saúde; Estilo de vida pessoal; Gênero; Cultura; Educação; Redes de apoio social.	2, 3, 4 e 5.
Nota técnica nº 9/2023. Recomendação pelo não rastreamento populacional do câncer de próstata.		Serviços de saúde; Estilo de vida pessoal; Gênero; Cultura; Condições de trabalho.	1, 2, 4 e 5

continua...

Promoção da Saúde			
Documento, ano e ação:	Com quem devemos agir?	Em que devemos agir?	Como devemos agir?
Resolução nº 719/2023. Expansão da diretriz de integralidade da atenção a grupos vulneráveis como os homens.	Indivíduo; Família; Comunidade; Setor/Sistema; Sociedade.	Serviços de saúde; Redes de apoio social; Estilo de vida pessoal; Gênero; Cultura; Educação; Renda e status social; Condições de trabalho; Ambiente físico; Biologia e genética.	1, 2, 3, 4 e 5
Orientação Técnica nº 1/2023. Traz ações integradas na área da saúde sexual e reprodutiva de homens e mulheres.		Serviços de saúde; Educação; Condições de trabalho; Renda e status social; Saúde pessoal e práticas e habilidades de enfrentamento.	1 e 5
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: plano de ação nacional 2009-2011.	Setor/Sistema; Sociedade.	Serviços de saúde; Saúde Pessoal e Práticas e Habilidades de Enfrentamento; Renda e status social; Condições de trabalho; Educação; Ambientes físicos; Rede de Apoio Social.	1, 2, 4 e 5
Portaria nº 2.634/2012. Repasse de recursos financeiros aos Municípios para a execução de ações de implantação, implementação, fortalecimento e/ou aperfeiçoamento de iniciativas prioritárias da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.		Serviços de saúde; Rede de apoio social.	1 e 5

continua...

Promoção da Saúde			
Documento, ano e ação:	Com quem devemos agir?	Em que devemos agir?	Como devemos agir?
Nota Técnica nº 3/2021. Apoio às Coordenações de saúde do homem dos estados e municípios.	Indivíduo; Comunidade; Setor/Sistema.	Serviços de saúde; Estilo de vida pessoal; Gênero; Cultura; Educação; Biologia e genética.	1, 2, 3, 4 e 5
Lei nº 14.443/ 2022. Técnica de contracepção para homens e mulheres.	Setorial/ Sistema de Saúde/ Social/ Sociedade.	Serviços de saúde; Gênero; Cultura; Estilo de vida pessoal; Educação.	1, 2 e 5
Nota Técnica nº 3/2022. Registro do pré-natal do pai-parceiro no sistema e-SUS APS.	Indivíduo; Família; Comunidade; Setor/Sistema.	Serviços de saúde; Estilo de vida pessoal; Desenvolvimento infantil saudável; Gênero; Cultura.	1, 2, 4 e 5
Nota Técnica nº 63/2023. Trata da inclusão de vítimas de violência sexual como grupo prioritário para vacinação contra o HPV, para pessoas de nove a 45 anos de idade, ainda não vacinados contra HPV.	Indivíduo; Setor/Sistema; Sociedade; Serviços de saúde.	Gênero; Cultura; Estilo de vida pessoal; Redes de apoio social.	1, 2 e 5
Lei nº 14.623/2023. Institui o dia nacional de conscientização sobre a paternidade responsável.	Indivíduo; Família; Comunidade; Sociedade.	Gênero; Cultura; Educação; Estilo de vida pessoal; Desenvolvimento infantil saudável.	1, 2 e 4

continua...

Promoção da Saúde			
Documento, ano e ação:	Com quem devemos agir?	Em que devemos agir?	Como devemos agir?
Nota técnica conjunta informativa relacionada à Lei nº 13.257/2016. Recomendações para participação do homem em programa ou atividade de orientação sobre paternidade em relação ao marco legal da primeira infância.	Indivíduo; Família; Comunidade; Setor/Sistema; Sociedade.	Desenvolvimento infantil saudável; Serviços de saúde; Redes de apoio social; Estilo de vida pessoal; Gênero; Cultura.	1, 2, 3, 4 e 5
Nota técnica nº 4/2023. Semana nacional de prevenção da gravidez na adolescência e diálogos com homens.	Indivíduo; Família; Comunidade; Setor/Sistema; Sociedade.	Educação; Serviços de saúde; Redes de apoio social; Estilo de vida pessoal; Gênero; Cultura.	
Lei nº 14.694/2023. Institui o novembrinho azul, a ser realizado no mês de novembro.	Indivíduo; Família; Comunidade; Setor/Sistema.	Desenvolvimento infantil saudável; Serviços de saúde; Educação; Estilo de vida pessoal; Cultura.	
Nota Técnica nº 34/2023. Orientações a gestores estaduais, municipais e DF sobre planejamento familiar (vasectomia).	Indivíduo; Setor/Sistema; Sociedade.	Serviços de saúde; Estilo de vida pessoal; Gênero; Cultura.	1, 4 e 5
Resolução nº 739/2024. Garantir a utilização dos campos de orientação sexual e identidade de gênero.	indivíduo; Família; Comunidade; Setor/Sistema; Sociedade.	Serviços de saúde; Redes de apoio social; Cultura; Gênero; Estilo de vida pessoal; Condições de trabalho.	1, 2, 3 e 4
Nota Técnica nº 5/2024. Orientações para a prevenção e o cuidado integral focado no câncer de pênis no Brasil.		Serviços de saúde; Estilo de vida pessoal; Gênero; Cultura; Renda e status social.	
Legenda: 1. Construção de políticas públicas saudáveis; 2. Desenvolvimento de habilidades pessoais; 3. Criação de ambientes favoráveis à saúde; 4. Fortalecimento da ação comunitária; 5. Reorientação dos serviços de saúde.			

Fonte: elaboração própria.

Com base nos documentos instrutivos/educativos, observa-se que, no que se refere a *com quem devemos agir*, há ênfase em múltiplos níveis sociais, com destaque para o indivíduo, especialmente em ações voltadas à saúde sexual, reprodutiva e paternidade. Famílias e comunidades também são alvo recorrente, sobretudo em estratégias educativas e de cuidado compartilhado. Setor/sistema aparece com frequência como nível de ação para qualificação do cuidado, enquanto a sociedade é envolvida em ações de enfrentamento das desigualdades e promoção da equidade.

Quanto a *em que devemos agir*, os principais determinantes sociais contemplados são os serviços de saúde e as práticas e habilidades individuais de enfrentamento. Também se evidenciam fatores como educação, rede de apoio social e condições de trabalho, além de aspectos como renda e status social, cultura, gênero, e desenvolvimento infantil saudável, demonstrando uma abordagem ampliada da determinação social da saúde. Em relação a *como devemos agir*, as estratégias priorizadas seguem os eixos da Carta de Ottawa, com predominância da reorientação dos serviços de saúde e da criação de ambientes favoráveis à saúde.

O desenvolvimento de habilidades pessoais e o fortalecimento da ação comunitária também se destacam. A construção de políticas públicas saudáveis aparece de forma consistente em documentos voltados à institucionalização dos direitos e diretrizes voltadas à saúde do homem (Quadro 2).

A síntese dos registros de instruções no âmbito da educação em saúde, com identificação (ID), suas denominações, principais ações, ano de publicação e as suas categorizações conforme os componentes do Modelo para Promoção da Saúde da População está presente no Quadro 2.

Quadro 2. Categorização dos documentos instrutivos/educativos. Salvador, Bahia, Brasil, 2025

Promoção da Saúde			
Documento/ação e ano	Com quem devemos agir?	Em que devemos agir?	Como devemos agir?
O percurso da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Homens desde a sua formulação até sua implementação nos serviços públicos locais de atenção à saúde (Leal; Figueiredo; Silva, 2012).	Setor/Sistema; Sociedade.	Serviços de Saúde; Redes de Apoio; Educação; Cultura; Gênero.	3 e 5
Boletim temático da biblioteca do Ministério da Saúde: saúde do homem (Brasil, 2021f).		Serviços de saúde; Condições de trabalho; Saúde Pessoal e Práticas de Saúde.	
Fortalecimento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: compromisso versus ação na Atenção Básica (Inca, 2013).		Serviços de saúde; Redes de apoio social; Gênero; Cultura.	
Amigo, gravidez, parto e cuidado também são coisas de homem. Seja pai, esteja presente (Brasil, 2014a).	Indivíduo; Família; Comunidade; Setor/Sistema.	Serviços de Saúde; Orientação Profissional; Redes de Apoio; Educação.	3
Guia do pré-natal do parceiro para profissionais de saúde (Brasil, 2023h).		Serviços de saúde; Saúde Pessoal e Práticas e Habilidades de Enfrentamento; Educação; Saúde Desenvolvimento Infantil; Rede de Apoio Social.	1, 2, 4 e 5
Sumário de evidências sobre a participação social do pai e/ou parceiro no pré-natal (Brasil, 2023i).		Serviços de saúde; Condições de trabalho; Saúde Pessoal e Práticas de Saúde.	1 e 5
Homens gays e bissexuais: direitos, saúde e participação social (Brasil, 2016d).		Orientação Profissional; Redes de Apoio; Educação; Grupos Comunitários.	3 e 5

continua...

Promoção da Saúde			
Documento/ação e ano	Com quem devemos agir?	Em que devemos agir?	Como devemos agir?
Caderno de Atenção Básica: saúde sexual e saúde reprodutiva (Brasil, 2013b).	População em Geral; Indivíduo; Família; Setor/Sistema.	Serviços de Saúde; Redes de Apoio; Educação; Cultura.	3
Guia do pré-natal do parceiro para profissionais de saúde (Brasil, 2016c).	Setor/Sistema; Sociedade; Profissional.	Orientação Profissional; Redes de Apoio; Educação; Grupos Comunitários.	3 e 4
Guia de Saúde do Homem para Agente Comunitário de Saúde – ACS (Brasil, 2024c).	Setor/Sistema; Sociedade; Profissional.	Orientação Profissional; Redes de Apoio; Educação;	2 e 3
II Relatório da pesquisa saúde do homem, paternidade e cuidado Brasil (Brasil, 2017c).	Indivíduo; Família; Comunidade; Setor/Sistema; Sociedade.	Serviços de saúde; Saúde Pessoal e Práticas e Habilidades de Enfrentamento; Educação; Condições de trabalho; Rede de Apoio Social.	1, 2, 4 e 5
Saúde sexual e saúde reprodutiva: os homens como sujeitos de cuidado (Brasil, 2018c).		Serviços de saúde; Saúde Pessoal e Práticas e Habilidades de Enfrentamento; Educação; Condições de trabalho; Renda e status social; Rede de Apoio Social.	
Homens trans: vamos falar sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis? (Brasil, 2019a).		Saúde Pessoal e Práticas e Habilidades de Enfrentamento; Saúde Desenvolvimento Infantil; Educação; Serviços de saúde; Rede de Apoio Social.	
Como envolver o homem trabalhador no planejamento reprodutivo, pré-natal, parto e desenvolvimento da criança (Brasil, 2018g).		Saúde Pessoal e Práticas e Habilidades de Enfrentamento; Serviços de saúde; Educação; Rede de Apoio Social; Condições de trabalho.	1, 2, 3 e 4

continua...

Promoção da Saúde			
Documento/ação e ano	Com quem devemos agir?	Em que devemos agir?	Como devemos agir?
Guia para oferta de prevenção combinada ao HIV, com Foco em PrEP e PEP, para pessoas trans, travestis e não binárias (Brasil, 2024d).	Indivíduo; Comunidade; Setor/Sistema; Sociedade.	Renda e status social; Rede de Apoio Social; Educação; Condições de trabalho; Saúde Pessoal e Práticas e Habilidades de Enfrentamento; Serviços de saúde.	1, 2, 3, 4 e 5
Dados da morbimortalidade masculina no Brasil (Brasil, 2017d).	Indivíduo; Setor/Sistema; Sociedade.	Serviços de saúde; Rede de Apoio; Educação; Condições de Trabalho; Renda e Status Social.	1, 2, 4 e 5
I simpósio de saúde sexual e saúde reprodutiva masculina e encontro nacional de coordenadores de saúde do homem: relatório final (Brasil, 2018d).	Indivíduo; Comunidade; Setor/Sistema; Sociedade.	Serviços de saúde; Educação; Saúde Pessoal e Práticas e Habilidades de Enfrentamento; Rede de Apoio Social.	2, 4 e 5
Saúde do Homem: projeto de terminologia da saúde (Brasil, 2018e).	Indivíduo; Comunidade; Setor/Sistema; Sociedade.	Serviços de saúde; Educação; Saúde Pessoal e Práticas e Habilidades de Enfrentamento.	1, 2 e 5
Relatório da pesquisa saúde do homem, paternidade e cuidado Brasil - III etapa (Brasil, 2018f).	Indivíduo; Comunidade; Setor/Sistema.	Serviços de saúde; Condições de trabalho; Educação; Rede de Apoio Social.	
Cartilha para pais. Como exercer uma paternidade ativa (Brasil, 2018h).	Indivíduo; Família; Comunidade; Sociedade.	Rede de Apoio Social; Educação; Saúde Desenvolvimento Infantil; Saúde Pessoal e Práticas e Habilidades de Enfrentamento; Serviços de saúde.	1, 2, 4 e 5
Licença-paternidade um direito do pai (Brasil, 2018i).	Indivíduo; Família; Setor/Sistema.	Serviços de saúde; Saúde Pessoal e Práticas e Habilidades de Enfrentamento; Saúde Desenvolvimento Infantil; Rede de Apoio Social; Educação.	

continua...

Promoção da Saúde			
Documento/ação e ano	Com quem devemos agir?	Em que devemos agir?	Como devemos agir?
Câncer de próstata: vamos falar sobre isso? (Brasil, 2019b).	Indivíduo; Comunidade; Setor/Sistema.	Serviços de saúde; Saúde Pessoal e Práticas e Habilidades de Enfrentamento; Educação.	2, 4 e 5
Cartão saúde do caminhoneiro (Brasil, 2020a).	Indivíduo.	Saúde Pessoal e Práticas e Habilidades de Enfrentamento; Serviços de saúde; Rede de Apoio Social; Educação; Condições de trabalho.	1, 2, 3 e 5
Homem se cuide, o melhor da vida é ter saúde (Brasil, 2020b).	Indivíduo; Comunidade.	Saúde Pessoal e Práticas e Habilidades de Enfrentamento; Rede de Apoio Social; Serviços de saúde.	2, 4 e 5
Homem, Cuide-se! O melhor da vida é ter saúde: com a cultura de paz, sua saúde ganha uma grande aliada (Brasil, 2020c).		Saúde Pessoal e Práticas e Habilidades de Enfrentamento; Rede de Apoio Social; Serviços de saúde.	
Homem, cuide-se! O melhor da vida é ter saúde: pai planeja, pai participa, pai cuida e se cuida (Brasil, 2020d).		Saúde Pessoal e Práticas e Habilidades de Enfrentamento. Rede de Apoio Social; Serviços de saúde	
Estratégia de Qualificação Profissional para a Saúde do Homem (Ferreira, 2024).	Setor/Sistema; Sociedade; Profissional.	Educação; Habilidades de Enfrentamento; Serviços de saúde.	2, 3 e 5
Legenda: 1. Construção de políticas públicas saudáveis; 2. Desenvolvimento de habilidades pessoais; 3. Criação de ambientes favoráveis à saúde; 4. Fortalecimento da ação comunitária; 5. Reorientação dos serviços de saúde.			

Fonte: Elaboração própria.

Todos os registros analisados e inseridos na amostra final trazem em seu arcabouço a saúde do homem transversalizada em ações de educação e promoção da saúde e prevenção de agravos.

Discussão

Os achados deste estudo possibilitaram ilustrar os elementos constitutivos da Promoção da Saúde refletida nas ações governamentais brasileiras que contemplam as demandas e necessidades de saúde dos homens no país.

O acesso e atendimento dos homens aos serviços de saúde apresenta-se como um desafio. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que os homens enfrentam um risco maior de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, devido a uma combinação de fatores biológicos, normas sociais e comportamentos de saúde (OMS, 2024). Além disso, cabe enfatizar a predominância do modelo biomédico, centrado na doença, no corpo físico e na intervenção curativa, o que reforça uma abordagem fragmentada do cuidado (Registro; Elias; Seti, 2025). Essa lógica pouco dialoga com as especificidades de gênero, especialmente com a socialização masculina que desestimula o autocuidado e a busca por ajuda, afastando-os ainda mais dos serviços de saúde.

A percepção do cuidado entre os profissionais de saúde, especialmente no que diz respeito ao cuidado dos homens, tem evoluído significativamente. Há um movimento para reconhecer a importância de habilitar e torná-los protagonistas no autocuidado, por meio de educação e comunicação contínua. Especialmente na consulta de enfermagem, teorias como a Teoria do Autocuidado têm sido utilizadas para guiar a assistência, com foco na promoção do autocuidado, primando pelo respeito à autonomia e à individualidade do homem (Santos *et al.*, 2020).

Sobre ações realizadas, estudo realizado na Austrália abordou homens rurais em situação de risco em um evento agrícola e comprovou ser um ambiente eficaz para a promoção da saúde. Detectou que 58,9% de 401 homens com idade média de 56 anos estavam com pressão alta e circunferência abdominal acima do recomendado comparados a outras populações masculinas também rurais, com diferença significativamente maior na faixa etária de 45 a 54 anos. Essa contribuição, baseada em evidências sobre a Estratégia Nacional de Saúde Masculina 2020-2030, no país australiano, investiu em um programa de extensão que conecta homens em ambientes

sociais/profissionais apropriados, para que encaminhamentos sejam realizados, principalmente para o controle da hipertensão (Seaman; Green; Smith, 2021).

Outra investigação apresentou um modelo integrado de urologia e atenção primária que acompanhou 81 homens com deficiência de testosterona, fornecendo a eles novos diagnósticos, prescrições medicamentosas, encaminhamentos para a nutrição por conta de sobrepeso e medicina do sono para tratar apneia obstrutiva, além de atualização de vacinações e colonoscopia de triagem. Destes, 41% não tinham um prestador de cuidados primários preexistente, um modelo que indicou maior acesso a encaminhamentos para subespecialidades, perda de peso objetiva e rastreamento do câncer (Nguyen *et al.*, 2023).

Realmente existem lacunas dentre as evidências científicas que implementam os objetivos das políticas de saúde do homem e da promoção da saúde em conjunto. Com isso, tais entrelinhas precisam ser superadas por meio do fortalecimento e da articulação de políticas públicas intersetoriais, que integrem ações de promoção da saúde que considerem as especificidades masculinas, de modo a assegurar efetiva implementação de programas de saúde, para reduzir as desigualdades em saúde (Brandão *et al.*, 2025). Alguns documentos revisitados neste estudo não constavam nas páginas oficiais sendo alguns deles retirados pela gestão federal do governo da época, a exemplo de documentos direcionados à saúde de homens gays, bissexuais e transgêneros.

A Política Nacional de Promoção da Saúde – PNPS (Brasil, 2018b), ao enfatizar os princípios de participação social, empoderamento, equidade e outros, serve como um referencial importante para as ações voltadas à saúde dos homens. Observou-se forte consonância com esses princípios, principalmente aos da promoção da equidade e do enfrentamento das desigualdades em saúde, mediante a marginalização histórica de grupos populacionais como os homens negros, indígenas (Cordero; Saletti-Cuesta, 2025; Cenedesi Júnior *et al.*, 2024). Outrossim, integrar políticas públicas com o enfoque na promoção da saúde no atendimento às necessidades em consideração as intersecções de marcadores sociais da diferença (Brasil, 2009a, 2013a, White; Tod, 2022).

No que tange ao histórico da participação social na criação da PNAISH, aspecto importante no âmbito da promoção da saúde populacional, ocorreu fragmentada, sem diálogo ou troca ampla, carecendo de ampliação (Hemmi; Baptista; Rezende, 2020, p. 23). Ressalta-se a superação da visão biológica da saúde masculina, para

a inclusão de modelos promotores da saúde dos homens mediante as diferenças identitárias, marcadas pelos determinantes sociais da saúde, com ampliação para a dimensão familiar, dos sistemas de saúde e da sociedade (Hemmi; Baptista; Rezende, 2020, p. 24; Hamilton; Bhatti, 1996).

A promoção da equidade na saúde masculina, no Brasil, reflete os desafios globais enfrentados em outros países em relação às disparidades socioeconômicas e ao acesso à saúde (Paula *et al.*, 2022; Smith *et al.*, 2020). Em íntimo diálogo com o previsto da Carta de Ottawa, é imprescindível que as iniciativas públicas de promoção da saúde dos homens reforcem ações comunitárias, num movimento protagonista de mediar, promover, desenvolver atitudes pessoais, e, por conseguinte, em termos macros, não perca de vista a reorganização dos serviços de saúde e o estabelecimento de uma política pública saudável (OMS, 1986; Hamilton; Bhatti, 1996).

No caso particular do Brasil, o SUS visa abordar essas questões por meio de políticas direcionadas, como a PNAISH, que reconhece as necessidades únicas na saúde de homens e o impacto das normas de gênero nos resultados (Lima; Schwarz, 2018). Tal premissa reflete esforços internacionais amplos na promoção da saúde – políticas públicas saudáveis e equidade – ao enfatizar a necessidade de intervenções específicas que considerem os determinantes sociais da saúde (Smith *et al.*, 2020; Griffith *et al.*, 2021; Hamilton; Bhatti, 1996).

A efetividade dessas políticas é frequentemente limitada pelo subfinanciamento e apoio institucional inadequado, o que pode impactar no desenvolvimento de habilidades pessoais essenciais à promoção de vida saudável e desfavorecer a criação de ambientes saudáveis. Diante disso, a promoção da saúde, equidade e inclusão social devem estar no centro e não de forma aspiracional, cujas ações para a saúde dos homens sejam integrais (Funcia, 2019; Smith *et al.*, 2020; Hamilton; Bhatti, 1996). Tal financiamento em saúde pública, no Brasil, tem sido historicamente insuficiente, o que resulta em prejuízos ao acesso integral, universal e equitativo (Souza, 2020), cenário agravado por Emendas Constitucionais, relacionadas ao "teto de gastos" que repercutem em impactos negativos para efetividade das ações planejadas em qualidade prestada (Almeida; Gonçalves; Nunes, 2021; Sousa *et al.*, 2021).

Sob a ótica da Promoção da Saúde, a garantia da reorientação dos serviços de saúde também deve estar alinhada à revisão de investimentos em ações promotoras da saúde que não percam de vista o fortalecimento da ação comunitária nesse processo (Hamilton; Bhatti, 1996).

A integralidade da saúde masculina foi abordada de maneira diversificada nos documentos analisados; a PNAISH (Brasil, 2009a) foi ratificada pela Portaria nº 3.562/2021 (Brasil, 2021a), destacando a necessidade de um cuidado além da atenção às doenças, incorporando a promoção da saúde, a prevenção de agravos e o cuidado ao longo do ciclo de vida do homem. É também abordada em guias e notas técnicas (Brasil, 2017a), fortalecendo o pré-natal do pai-parceiro e sua participação ativa nas consultas de saúde reprodutiva/familiar. A implementação dessas ações na APS ainda enfrenta desafios operacionais, como a escassez de profissionais capacitados e a dificuldade de engajamento dos homens nas unidades de saúde e questões culturais, pois muitos homens só procuram os serviços de saúde quando já estão doentes, o que compromete o impacto das políticas preventivas (Roudsari; Sharifi; Goudarzi, 2023).

Estudos sobre a implementação da PNAISH indicam que mesmo com a presença de ações direcionadas à saúde masculina ainda não estão suficientemente consolidadas na prática da APS (Sousa *et al.*, 2021; Paula *et al.*, 2022). As ações voltadas para a saúde sexual/reprodutiva (Brasil, 2024a) são exemplos de intervenções promissoras, mas sua efetividade depende do envolvimento ativo dos profissionais de saúde e da mudança na percepção social do papel dos homens no autocuidado em saúde.

A participação social foi amplamente enfatizada e estratégias como o fortalecimento da participação masculina no planejamento familiar, no pré-natal e na paternidade ativa são recorrentes nas políticas governamentais. A Lei nº 14.623/2023 (Brasil, 2023d) institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável e as orientações sobre o pré-natal do parceiro. Pesquisas revelam que fatores como barreiras culturais, normas de gênero e o estigma relacionado à masculinidade dificultam a plena participação dos homens nesses programas (Smith *et al.*, 2020; Griffith *et al.*, 2021; Oliveira *et al.*, 2020; Alves *et al.*, 2020; Lima; Schwarz, 2018).

A inclusão de ações que buscam sensibilizar homens sobre seus direitos e responsabilidades no cuidado com a licença-paternidade, reforça a importância de um modelo de saúde que os reconheça não apenas como receptores de cuidado, mas como atores ativos na promoção da saúde familiar (Brasil, 2023i). Os documentos encontrados neste estudo ilustram a busca pelo protagonismo social masculino.

A promoção do autocuidado e empoderamento dos homens para que assumam a responsabilidade por sua saúde foram destacados em várias iniciativas, como na campanha “Homem, Cuide-se!” (Brasil, 2020c; 2020d; 2021f) e a cartilha sobre

paternidade ativa (Brasil, 2018i). Alguns documentos focam na promoção da conscientização sobre a prevenção de doenças crônicas, câncer de próstata e violência. No entanto, a eficácia dessas ações educativas depende de uma comunicação clara e acessível que dialogue com a realidade dos homens (Alves *et al.*, 2022).

A implementação de programas de rastreamento, como o do câncer de próstata, desempenha papel crucial na APS, uma vez que reforça seu papel como porta de entrada preferencial para o cuidado integral e preventivo. No entanto, a persistência de subnotificação de casos e a elevada mortalidade evitável entre homens indicam desafios significativos na efetivação dessas ações (Ribeiro *et al.*, 2024), o que reforça a necessidade de estratégias mais eficazes que englobam educação em saúde, ampliação do acesso e acolhimento específico para superar as barreiras culturais e estruturais que limitam o impacto das ações de rastreamento.

A intersetorialidade se relaciona de maneira muito próxima do público de lésbicas, *gays*, bissexuais, travestis e transexuais (Brasil, 2013a). Ademais, a territorialização das ações, especialmente em regiões rurais e periféricas, foi uma constante nos documentos, visando garantir que os homens, independentemente de sua localização geográfica, tenham acesso a cuidados de saúde adequados. A implementação de ações intersetoriais, como abordagens conjuntas com programas de prevenção à violência, é fundamental para a efetividade das políticas (Oliveira *et al.*, 2022). No entanto, a execução dessas políticas intersetoriais carece de maior articulação entre os diversos níveis de governo, o que ainda representa um desafio para a plena implementação da PNPS e da PNAISH.

A necessidade de adaptar as ações de saúde para diferentes grupos de homens, como homens trans, negros e em situação de vulnerabilidade social é um ponto crítico abordado, pois documentos voltados para a prevenção combinada ao HIV em homens trans é um exemplo de política que busca atender as especificidades desse grupo (Brasil, 2013a, 2019a, 2024d). Além disso, as políticas voltadas para a saúde do homem no contexto de violência também refletem o reconhecimento da diversidade das necessidades de saúde masculina (Brasil, 2024d; Ferreira, 2024).

As implicações significativas para a saúde coletiva necessitam ser destacadas, especialmente no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); a promoção da saúde, a redução das desigualdades e a garantia de acesso universal aos serviços de saúde estão entre os ODS, refletidos, ainda que de forma limitada, nas políticas examinadas. Torna-se evidente a necessidade de maior alinhamento das

ações governamentais com esses objetivos no que diz respeito à promoção da saúde, prevenção de doenças e equidade de gênero – áreas que continuam a receber menos recursos e a enfrentar maior negligência (Miranda *et al.*, 2023).

Este estudo traz como potencialidades a unificação de uma série de documentos normativos e educativos publicados pelo governo federal brasileiro que poderá ser utilizado por profissionais e trabalhadores de saúde, bem como gestores que almejam desenvolver ou fortalecer as práticas em saúde voltadas ao público masculino, e identifica os princípios da PNPS que ainda não foram plenamente contemplados orientando esforços futuros.

Há limitações no presente estudo: restrição imposta pelas plataformas de busca, que não aceitam operadores booleanos foi encontrada, o que pode ter excluído estudos importantes, impactando a abrangência e profundidade da análise – os resultados apresentados devem ser interpretados considerando essas restrições metodológicas. Outra limitação foi que alguns documentos foram categorizados de acordo com a categoria predominante dos princípios e objetivos da PNPS, mesmo que alguns apresentassem conteúdos relacionados a mais de uma categoria, restringindo os resultados a uma análise mais objetiva, podendo não refletir a complexidade de seus conteúdos.

Para finalizar, o redirecionamento e a avaliação sistemática das ações e programas podem potencializar a promoção da saúde masculina e ampliar o cuidado integral, abordando as múltiplas formas de vivenciar as masculinidades na sociedade, o que contribuirá para a redução de riscos a patologias e para a melhoria da qualidade de vida dos homens, consolidando uma atenção mais equitativa e eficaz neste complexo campo de invulnerabilidades.

Considerações finais

As ações governamentais brasileiras voltadas à Saúde do Homem, no contexto da APS, configuram-se como um esforço relevante, mas ainda marcado por limitações. As análises evidenciam avanços e desafios, e há iniciativas importantes na formulação de políticas públicas, mas sua implementação enfrenta barreiras culturais, estruturais e financeiras. Para alcançar resultados mais efetivos, é necessário que as políticas sejam inclusivas, sensíveis às especificidades regionais e sociais e que contenham financiamento sustentável e estratégias integradas intersetoriais.

A análise à luz do Modelo Integrado de Saúde da População e Promoção da Saúde indica que há foco em diversos níveis sociais. Em relação a quem devemos agir, famílias e comunidades são constantemente alvo de estratégias educativas e de cuidado compartilhado. Já em relação ao que devemos agir, o foco está nos serviços de saúde, bem como nas práticas e habilidades individuais de enfrentamento. Ao levar em conta elementos como educação, rede de apoio social e condições de trabalho, além de fatores como renda, cultura e gênero, emerge uma perspectiva mais abrangente. No que diz respeito às nossas ações, as estratégias priorizadas estão alinhadas com os eixos da Carta de Ottawa, concentrando-se na reorientação dos serviços de saúde, no desenvolvimento de habilidades pessoais e no fortalecimento da ação comunitária.²

Agradecimentos

Agradecemos o apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).

Referências

- ALMEIDA, J. C.; GONÇALVES, R. S.; NUNES, A. Quality of spending and budgetary allocation to health: an analysis in primary care in Brazilian cities. *Rev. Gest. Saúde (Brasília)*, v. 12, n. 1, p. 19-35, 2021.
- ALVES, A. N.; COURA, A. S.; FRANÇA, I. S. X.; MAGALHÃES, I. M. O.; ROCHA, M. A.; ARAÚJO, R. S. Access of first contact in the primary health care: an evaluation by the male population. *Rev. bras. epidemiol. (Online)*, v. 23, p. E200072, 2020. <https://doi.org/10.1590/1980-549720200072>
- ALVES, A. N.; TOMAZ, A. P. S.; MAGALHÃES, I. M. O.; RAMOS, R. A. Ações educativas para a promoção da saúde do homem na atenção primária: revisão integrativa. *Rev. APS (Online)*, v. 25, n. 2, p. 430-45, 2022. <https://doi.org/10.34019/1809-8363.2022.v25.30168>
- BELOTTI, M.; IGLESIAS, A.; AVELLAR, L. Z. Análise documental sobre as normativas do trabalho no núcleo ampliado de saúde da família. *Psicol. ciênc. prof.*, v. 39, p. e185025, 2019. <https://doi.org/10.1590/1982-3703003185025>
- BERBEL, C. M. N.; CHIRELLI, M. Q. Reflexões do cuidado na saúde do homem. *Rev. bras. promoç. saúde.*, v. 33, p. 1-9, 2020.

BORGES, C. C. L.; DE SOUSA, A.; ARAÚJO, I.; ORTIZ RODRÍGUEZ, J.; ESCOBAR, O, *et al.* A scoping review of men's health situation in primary health care. *The Open Nursing Journal*, v. 15, p. 412, 2021.

BRANDÃO, C. C. *et al.* Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: 15 anos de importantes avanços e persistentes desafios. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*, v. 29, supl. 1, e250258, 2025. <https://doi.org/10.1590/interface.250258>

BRASIL. Lei nº 14.623, de 17 de julho de 2023. Institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável, a ser comemorado, anualmente, em 14 de agosto. *Diário Oficial da União*. Brasília, 2023d.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Homem se cuida, o melhor da vida é ter saúde – jovem*. Brasília: Ministério da Saúde, 2020c.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Homem se cuida, o melhor da vida é ter saúde – paternidade*. Brasília: Ministério da Saúde, 2020d.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. *Política nacional de atenção integral à saúde do homem (princípios e diretrizes)*. Brasília: Ministério da Saúde, 2008a.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. *Perfil da morbimortalidade masculina no Brasil*. Brasília: Ministério da Saúde, 2018a.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde. *Sumário de evidências participação do pai elou parceiro no pré-natal*. Brasília: Ministério da Saúde, 2023i.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. *Guia para oferta de prevenção combinada ao HIV, com foco em PrEP e PEP, para pessoas trans, travestis e não binárias*. Brasília: Ministério da Saúde, 2024d.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. *Homens trans: vamos falar sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis?* Brasília: Ministério da Saúde, 2019a.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. *Política nacional de promoção da saúde (PNPS): anexo I da portaria de consolidação n. 2, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do SUS*. Brasília: Ministério da Saúde, 2018b.

BRASIL. Ministério da Saúde. Serviço Social do Transporte. Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. *Cartão saúde do caminhoneiro*. Brasília: Ministério da Saúde, 2020a.

BRASIL. Portaria nº 1.474, de 8 de setembro de 2017. Inclui e altera procedimento na tabela de procedimentos, medicamentos, órteses/ próteses e materiais do sus. *Diário Oficial da União*. Brasília, 2017a.

BRASIL. Portaria nº 1.944, de 27 de agosto de 2009. Institui no âmbito do sistema único de saúde (SUS), a política nacional de atenção integral à saúde do homem. *Diário Oficial da União*. Brasília, 2009a.

BRASIL. Portaria nº 2.836, de 1º de dezembro de 2011. Institui a política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. *Diário Oficial da União*. Brasília, 2013a.

BRASIL. Portaria nº 3.562, de 15 de dezembro de 2021. Altera o anexo XII da portaria de consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a política nacional de atenção integral à saúde do homem (PNAISH). *Diário Oficial da União*. Brasília, 2021a.

CARLOS, D. J. D.; BELLAGUARDA, M. L. DOS R.; PADILHA, M. I. O documento como fonte primária nos estudos da enfermagem e da saúde: uma reflexão. *Escola Anna Nery*, v. 26, p. e20210312, 2022. <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2021-0312>

CENEDESI JÚNIOR, M. A.; PINTO, P. R. F.; SANTOS, P. R.; NASCIMENTO, A.; SILVA, S. M. A.; JUNQUEIRA, S. L. S. S. *et al.* As particularidades do cuidado à saúde do homem – aspectos teóricos. *Int J Humanit Soc Sci.*, v. 29, n. 4, p. 60-4, 2024.

CHAN, Y. Y. T.; WONG, W. C. W. *Global implementation of primary health care*. In: FONG, B. Y. F.; WONG, W. C. W. (org.). *Gaps and actions in health improvement from Hong Kong and beyond*. Singapore: Springer, 2023.

CORDERO, M. L.; SALETTI-CUESTA, L. Barreras y estrategias para la accesibilidad a la salud de las personas trans en Córdoba, Argentina. *Salud Colect.*; v. 21, p. e5200, 2025. <https://doi.org/10.18294/sc.2025.5200>

CUNHA, C. G. S. C. Avaliação de políticas públicas e programas governamentais: tendências recentes e experiências no Brasil. *Revista Estudos de Planejamento*, v. 12, p. 27-57, 2018.

DUARTE, S. J. H.; OLIVEIRA, J. R.; SOUZA, R. R. A política Saúde do Homem e sua operacionalização na Atenção Primária à Saúde. *Revista Eletrônica Gestão & Saúde*, v. 3, n. 1, p. 308-317, 2012.

DOS SANTOS, W. S. S.; BARROS, A. K. da S.; DE OLIVEIRA, S. J.; DA CRUZ, I. M. A. *et al.* Men's health in primary care: challenges faced by nurses regarding the determinants of the health-disease process. *CONTRIBUCIONES A LAS Ciencias Sociales*, v. 17, n. 2, p. e3959, 2024. <https://doi.org/10.55905/revconv.17n.2-062>

FERREIRA, Andreia. Estratégia de enfrentamento da violência de gênero é lançada pelo Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/dezembro/estrategia-de-enfrentamento-da-violencia-de-genero-e-lancada-pelo-ministerio-da-saude#:~:text=Sobre%20o%20curso,facilitam%20e%20dificultam%20as%20a%C3%A7%C3%B5es>. Acesso: 20 jan. 2025.

FIGUEIREDO, W. Assistência à saúde dos homens: um desafio para os serviços de atenção primária. *Ciênc. Saúde Colet.*, v. 10, n. 1, p. 105-9, 2005.

FUNCIA, F. R. Subfinanciamento e orçamento federal do SUS: referências preliminares para a alocação adicional de recursos. *Ciênc. Saúde Colet.*, v. 24, n. 12, p. 4405-15, 2019.

GRIFFITH, D. M.; BERGNER, E. M.; FAIR, A. S.; WILKINS, C. H. Using mistrust, distrust, and low trust precisely in medical care and medical research advances health equity. *Am J Prev Med.*, v. 60, n. 3, p. 442-45, 2021.

HAMILTON, N.; BHATTI, T. *Promoção da Saúde da População: Um Modelo Integrado de Saúde da População e Promoção da Saúde*. Ottawa: Divisão de Desenvolvimento da Promoção da Saúde, 1996.

HEMMI, A. P. A.; BAPTISTA, T. W. F.; REZENDE, M. O processo de construção da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. *Physis*, v. 30, n. 3, p. e300321, 2020. <https://doi.org/10.1590/S0103-73312020300321>

INSTITUTONACIONALDESAÚDEDAMULHER,DACRIANÇAEDOADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA. *Fortalecimento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH): compromisso versus ação na atenção básica*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2013.

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Nota técnica conjunta nº. 001, de 26 de junho de 2015. Posicionamento do ministério da saúde acerca da integralidade da saúde dos homens no contexto do novembro azul. *Secretaria de Atenção à Saúde*. Brasília, 2015.

LEAL, A. F.; FIGUEIREDO, W. S.; SIVA, G. S. N. Charting the Brazilian Comprehensive Healthcare Policy for Men (PNAISH), from its formulation through to its implementation in local public health services. *Ciênc. Saúde Colet.*, v. 17, n. 10, p. 2607-16, 2012.

LIMA, D. C.; SCHWARZ, E. The brazilian national policy of comprehensive healthcare to men. *Int J Mens Soc Community Health*, v. 1, n. 1, p. e36-e49, 2018. <https://doi.org/10.22374/ijmsch.v1iSP1.2>

MIRANDA, J. J.; SCHOLZ, I.; AGARD, J.; AL-GHANIN, K; BOBYLEV, S. N.; DUBE, O. P. *et al.* Times of crisis, times of change: science for accelerating transformations to sustainable development. New York: United Nations, 2023.

NASCIMENTO, C. A. Do governo dos homens... e das almas. *Rev. Bras. Educ.*, v. 23, p. e230014, 2018. <https://doi.org/10.1590/S1413-24782018230014>

- NGUYEN, V.; BERRIOS, S. E.; LEONARD, A.; BYRNE, E. R. *et al.* Integrated urology and primary care model improves outcomes for men with testosterone deficiency. *Urology Practice*, v. 10, n. 6, p. 673-678, 1 nov. 2023.
- OLIVEIRA, D. C. N.; LICO, F. M. C.; PEREIRA, H. M. S.; REGINA, F. L.; PERES, M. F. T. Intersectorality and health in state public security and violence prevention policies in Brazil. *Ciênc. Saúde Colet.*, v. 27, n. 4, p. 1301-16, 2022.
- OLIVEIRA, J. A.; ARAÚJO, I. F. M.; SILVA, G. T. R.; SOUSA, A. R.; PEREIRA, A. Strategies and competences of nurses in men's health care: an integrative review. *Rev. Bras. Enferm. (Online)*, v. 73, n. 6, p. 1-11: e20190546, 2020. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0546>
- PAGE, M. J.; MCKENZIE, J. E.; BOSSUYT, P. M.; BOUTRON, I. *et al.* Updating guidance for reporting systematic reviews: development of the PRISMA 2020 statement. *J Clin Epidemiol.*, v. 134, p. 103-12, 2021.
- PAULA, C. R.; LIMA, F. H.; PELAZZA, B. B.; MATOS, M. A. *et al.* Global challenges of health policies aimed at the male population: an integrative review. *Acta Paul Enferm.*, v. 35, p. eAPE01587, 2022. <http://dx.doi.org/10.37689/acta-ape/2022AR0001587>
- PINTO, L. F.; GIOVANELLA, L. Do programa à estratégia saúde da família: expansão do acesso e redução das internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB). *Ciênc. Saúde Colet.*, v. 23, n. 6, p. 1903-13, 2018.
- QUEIROZ, I. B. S.; SOUSA, A. S.; RANGEL, J. F.; SOUSA, L. S. *et al.* Analysis of male behavior towards primary health care services and recommended by PNAISH in the perception of nurses. *Amadeus International Multidisciplinary Journal*, v. 5, n. 9, p. 278-93, 2020.
- REGISTRO, M.; ELIAS, P. G.; SETI, M. E. R. Reflexões sobre o modelo biomédico e suas implicações no campo da saúde coletiva. *Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia*, v. 13, n. 1, p. 5061-5069, 2025.
- RIBEIRO, T. S.; SIMÕES, T. C.; SILVA, I. F.; KOIFMAN, R. J.; BORGES, M. F. S. O.; OPITZ, S. P. Effects of age, period, and cohort on mortality by prostate 1 cancer among men in the state of Acre, in the Brazilian Western Amazon. *Ciênc. Saúde Colet.*, v. 29, p. e14782022, 2024. <https://doi.org/10.1590/1413-81232024299.14782022EN>
- ROCHA, J. M.; LIMA, P. L. F.; SILVA, M. T. A.; LIMA, D. F. As compreensões da população masculina acerca do cuidado em saúde. *Rev. Ciênc. Plur.*, v. 8, n. 2, p. 1-14, 2022.
- ROUDSARI, R.L.; SHARIFI, F.; GOUDARZI, F. Barriers to the participation of men in reproductive health care: a systematic review and meta-synthesis. *BMC Public Health*, v. 23, n. 818, p. 1-37, 2023.
- SCHRAIBER, L. B.; GOMES, R.; COUTO, M. T. Homens e saúde na pauta da Saúde Coletiva. *Ciênc. Saúde Colet.*, v. 10, n. 1, p. 7-17, 2005.

SEAMAN, C. E.; GREEN, E.; SMITH, B. Reaching at-risk rural men: an evaluation of a health promotion activity targeting men at a large agricultural event. *Health Promotion Journal of Australia: official journal of Australian Association of Health Promotion Professionals*, v. 32, supl. 2, p. 65-71, 2021.

SANTOS, K. C. DOS, *et al.* Men's health care: construction and validation of a tool for nursing consultation. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 73, n. 3, p. e20190013, 2020. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0013>

SMITH, J. A.; GRIFFITH, D. M.; WHITE, A.; BAKER, P.; WATKINS, D. C.; DRUMMOND, M. *et al.* COVID-19, equity and men's health: using evidence to inform future public health policy, practice and research responses in pandemics. International. *Int J Mens Soc Community Health*, v. 3, n. 1, p. e48-e64, 2020. <https://doi.org/10.22374/ijmsch.v3i1.42>

SOUSA, A. R. Produzir cuidado à saúde de homens e suas masculinidades: uma prioridade. *REVISA*, v. 9, n. 4, p. 681-4, 2020.

SOUSA, A. R.; OLIVEIRA, J. Á.; ALMEIDA, M. S.; PEREIRA, Á.; ALMEIDA, É. S.; ESCOBAR, O. J. V. Implementação da política nacional de atenção integral à saúde do homem: desafios vivenciados por enfermeiras. *Rev. Esc. Enferm. USP*, v. 55, p. e03759, 2021. <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2020023603759>

SOUZA, D. O. O subfinanciamento do sistema único de saúde e seus rebatimentos no enfrentamento da Covid-19. *Physis (Online)*, v. 30, n. 3, p. e300313, 2020. <https://doi.org/10.1590/S0103-73312020300313>

WHITE, A.; TOD, M. The need for a strategy on men's health. *Trends in Urology and Men's Health.*, v. 13, n. 2, p. 2-8, 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Noncommunicable diseases*. Geneva: WHO, 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Ottawa Charter on Health Promotion*. Copenhagen: WHO, 1986.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *The 1st International Conference on Health Promotion, Ottawa, 1986*. Geneva: WHO, 1986.

Notas

¹ Acesso ao conteúdo na íntegra dos Quadros 1 e 2: <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/NQ5P9>

² C. C. L. Borges, A. L. Rabelo, V. de O. Muniz, N. M. P. V. Barreto e A. R. de Sousa: concepção, análise e interpretação dos dados; redação do artigo; revisão crítica relevante do conteúdo intelectual; aprovação final da versão a ser publicada. J. S. Araújo e R. S. Silva: redação do artigo; revisão crítica relevante do conteúdo intelectual; aprovação final da versão a ser publicada. Os autores são responsáveis por todos os aspectos do trabalho, garantindo a precisão e integridade de qualquer parte do trabalho.

Abstract

Men's health in Primary Care: An analysis of Brazilian government actions under Health Promotion

Men's health has been marked by patterns of illness and mortality that show inequalities in access to and use of health services, especially in Primary Health Care. The objective was to analyze documents on national government actions aimed at men's health care in the context of Primary Health Care under the lens of Health Promotion. This study was carried out between 2024 and 2025 within Brazilian normative, instructive, and educational documents available on government websites. The data was interpreted in the light of the Integrated Population Health and Health Promotion Model. Of the 55 records analyzed, 50.9% were instructive/educational, which demonstrated the “who”, ‘what’ and “how” of men's health promotion. The Brazilian government's actions aimed at Men's Health, in the context of Primary Care, are an important effort, but still marked by limitations; there are important initiatives in public policies, but implementation faces cultural, structural, and financial barriers. The categorization of actions is anchored in the pillars of health promotion, social participation, and empowerment, and highlights the need to improve more comprehensive strategies for specific populations.

► **Keywords:** Men's health. Primary Health Care. Health Promotion. Health Policy.